EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN DE TAMIZAJE DE CÁNCER DE MAMA

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	El cáncer de mama es el más frecuente y les causa la muerte a 685 000 mujeres en el mundo según la Organización Mundial de la Salud en el 2020; en donde la mayoría de estas fueron registrados en países de ingresos bajos y medios (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Para América Latina y el Caribe, el panorama es similar con una incidencia es de 210 000 mujeres y aproximadamente 68 000 muertes, ambas registradas para el 2020; haciendo que este cáncer sea el primero de la lista (OMS, s.f.). En Costa Rica este cáncer se encontraba en el primer lugar de incidencia y mortalidad en mujeres en el 2014, siendo las cifras más actualizadas del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud [MINSA], 2015; MINSA, 2019 & MINSA, 2021).
Evidencia	El tener un diagnóstico temprano de cáncer de mama es fundamental para que sea tratado oportunamente y de forma apropiada, lo que podría disminuir la mortalidad por este tipo de cáncer; por tanto, el tamizaje es de suma importancia y la mamografía “es la tecnología de imagen diagnóstica comprobadamente más eficaz” (Organización Mundial de la Salud, 2016). Además, la mamografía puede encontrar cambios en las mamas que potencialmente pueden llegar a ser cáncer, años antes de que existan síntomas en la paciente por lo que “las mujeres que se hacen mamogramas regularmente tienen más probabilidades de encontrar temprano el cáncer de seno, menos probabilidades de necesitar tratamiento agresivo, como cirugía para extirpar el seno (mastectomía) y quimioterapia, y más probabilidades de curarse” (American Cancer Society, 2019) La incorporación de esta intervención está acorde con la relevancia que ha venido tomando y las estrategias para su abordaje, se tomó como base el Decreto Nº38377-S, en el cual se instruye a realizar una mamografía de tamizaje a las mujeres de 45 a 70 años cada dos años, independientemente de sus factores de riesgo; y para las que se encuentren fuera de ese rango se debe tomar en cuenta los factores de riesgo y expectativa de vida para realizarle la mamografía de tamizaje (MINSA, 2014).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Utilización de bases manuales en los centros que no ingresan los datos en el sistema institucional. Falta de variable de área de salud de adscripción en listados extraídos del cubo de procedimientos. Estrategias: Solicitud de bases manuales a los centros que no ingresan los datos en el sistema institucional. Extracción del área de salud de adscripción del cubo de adscripción el primer día hábil posterior al cierre del periodo de evaluación
Normativa Técnica	Decreto N°43263-S: “Norma Nacional para la prevención y el manejo del cáncer de mama en Costa Rica” (noviembre, 2020)

Costo / Efectividad	En lo relativo a costo-efectividad los estudios relacionados varían en la edad que se debe hacer la mamografía, desde 40 a 75 años. Sin embargo, todos concuerdan que es una intervención costo-efectiva. Para un estudio realizado en Colombia la edad es de 50 a 69 años, teniendo un total de 742 años de vida salvados (Rúa, Avendaño, 2019). El tamizaje en mujeres de 50-69 años fue el más costo efectivo en relación con otros grupos etarios (40-49 y 70-75) (López, 2006). Dentro de un metaanálisis que incluye Brasil, Perú, México y Costa Rica, se observó que las maneras de aumentar la demanda dependen de cada país; sin embargo; "lo más provechoso en función del dinero invertido, sobre todo en el nivel poblacional, es una combinación de medidas de tamizaje […] y medidas terapéuticas" (Watkin *et al*, 2017). La OMS en las directrices sobre el tamizaje por mamografía sugiere que los programas relacionados a este tema sean organizados según los recursos disponibles y lo robusto del sistema de salud, indicando los grupos poblacionales y la frecuencia según su segregación. Sin embargo, refiere que "con recursos limitados y sistemas de salud deficientes, puede que los programas de tamizaje por mamografía de base poblacional no sean ni costo-efectivos ni factibles"
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar la cobertura de tamizaje de cáncer de mama realizadas por la CCSS a mujeres de 40 a 74 años; de forma institucional y distribuidos por área de salud de adscripción para su agrupación en RIPSS y área de salud, para contribuir a mejorar las estrategias de acceso y oportunidad.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la evolución de la cobertura institucional del tamizaje de cáncer de mama por medio de mamografía y su distribución por área de salud de adscripción según los resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPSS)?
Indicadores asociados a la intervención	09-03-1.0 Cobertura bienal de tamizaje de cáncer de mama con mamografía en mujeres de 40 a 74 años.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	American Cancer Society. (3 de octubre de 2019). Recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer para la detección temprana del cáncer de seno. https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-seno/pruebas-de-deteccion-y-deteccion-temprana-del-cancer-de-seno/guias-de-la-sociedad-americana-contra-el-cancer-para-la-deteccion-temprana-del-cancer-de-seno.html López, J. (2006). *Análisis coste-efectividad del cribado del cáncer de mama mediante mamografía en diferentes grupos de edad (40-49, 50 a 69 y 70 a 75)*. Canarias: Servicio Canario de la Salud, Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Ministerio de Salud [MINSA]. (20 de mayo de 2014). Decreto N°38377-S. Norma para la atención a personas con cáncer de mama. San José, Costa Rica. Ministerio de Salud [MINSA]. (2015). *Boletín estadístico de mortalidad por tumores malignos más frecuentes en Costa Rica del año 2014.* MINSA. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/estadisticas-y-bases-de-datos/estadisticas-y-bases-de-datos-vigilancia-de-la-salud/estadisticas-vigilancia-de-la-

salud/estadistica-de-cancer-registro-nacional-tumores/boletines-de-mortalidad-de-cancer/1726-boletin-de-mortalidad-por-cancer-2014/file

Ministerio de Salud [MINSA]. (2019). *Análisis de incidencia y mortalidad por cáncer.* MINSA. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/material-informativo/material-publicado/estadisticas-y-bases-de-datos/estadisticas-y-bases-de-datos-vigilancia-de-la-salud/estadisticas-vigilancia-de-la-salud/estadistica-de-cancer-registro-nacional-tumores

Ministerio de Salud [MINSA]. (2021). *427 mujeres fallecieron en el 2020 producto del cáncer de mama.* MINSA. https://www.ministeriodesalud.go.cr/ministeriodesaludbk/index.php/noticias/noticias-2017/1132-costa-rica-no-bajara-la-guardia-contra-el-zika

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2016). Garantía de la calidad de los servicios de mamografía: Normas básicas para América Latina y el Caribe. https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12681:manual-mamografia&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). *Cáncer de mama*. OMS. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (s.f.). *Cáncer de mama*. OMS. https://www.paho.org/es/temas/cancer-mama

Rúa, M y Avendaño, C. (2019). *Costo-Efectividad de la mamografía como prueba de tamizaje para la detección precoz el cáncer de mama*. Universidad de la Costa. http://hdl.handle.net/11323/3244

Watkin, D., Poggio, R., Augustovski, F., Brouwer, E., Pichon, R., Rubinstein, A; et al. (2017). *La costo-efectividad de las intervenciones y políticas para el control de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo en América Latina y el Caribe: revisión sistemática* (pp 109-112). Organización Panamericana de la Salud. https://iris.paho.org/handle/10665.2/33994